

ALGIES CRANIO- FACIALES

Pr ERRAMI Nouredine
Service ORL HMIMV Rabat Avril 2026

Objectifs du cours

- Reconnaître les principales caractéristiques des principales algies cranio-faciales
- Reconnaître les principes de la prise en charge de ces algies

INTRODUCTION

L'algie cranio- faciale est un motif de consultation qui est à cheval entre plusieurs spécialités : neurologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie..

L'approche diagnostique distinguera

- Algie faciale chronique vs Algie faciale aigue
- Algie primaire vs Algie secondaire

Le diagnostic est clinique

L'interrogatoire est un temps précieux.

L'examen physique cherche des signes d'appel orientant vers des douleurs secondaires à des affections graves

INNERVATION SENSITIVE DE LA FACE

L'innervation sensitive de la face est assurée par le nerf trijumeau, un nerf mixte à prédominance sensitive.

Il se divise en trois branches, **la branche V1 ou nerf ophtalmique**,
la branche V2 ou nerf maxillaire,
et **la branche V3 ou nerf mandibulaire**.

À la différence des nerfs sensitifs du reste du corps, le V est amené à innerver des tissus très variés (**la pulpe dentaire**, la **cornée**, les **méninges**, les **muqueuses**, la **peau**, le **tissu osseux**, l'**ATM**,

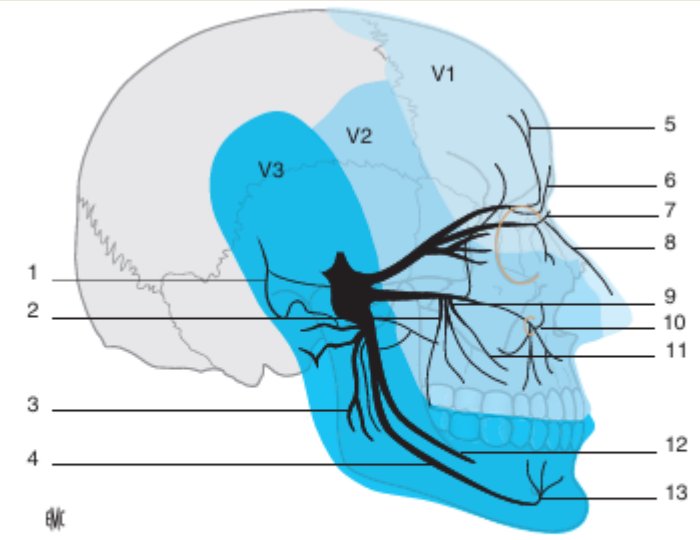
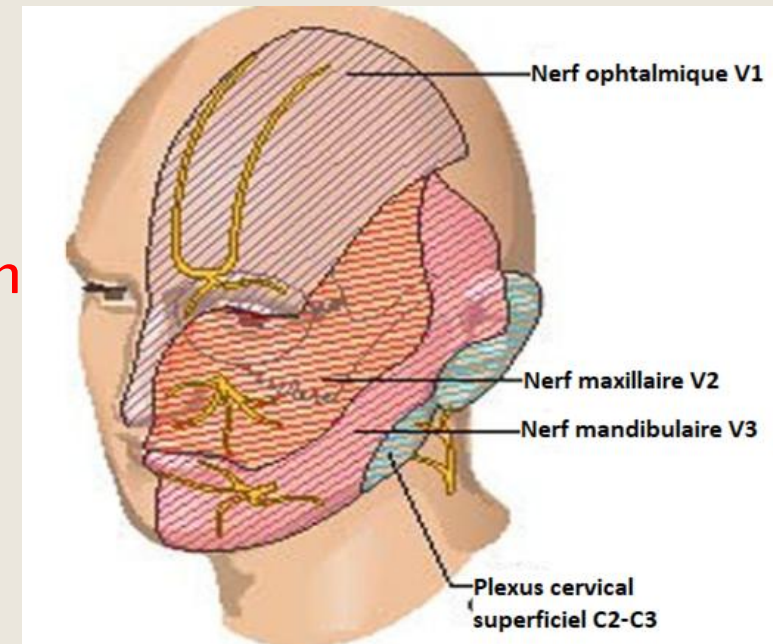


Figure 2. Territoire sensitif du trijumeau. V1 : nerf ophtalmique de Willis ; V2 : nerf maxillaire supérieur ; V3 : nerf maxillaire inférieur. 1. Nerf auriculotemporal ; 2. ganglion sphéno-palatin ; 3. nerf buccal ; 4. nerf alvéolaire ; 5. nerf frontal ; 6. nerf supratrochléaire ; 7. nerf infratrochléaire ; 8. nerf nasal interne ; 9. nerfs nasaux ; 10. nerf infraorbitaire ; 11. nerfs dentaires supérieurs ; 12. nerf lingual ; 13. nerf mentonnier.



Innervation sensitive auriculaire

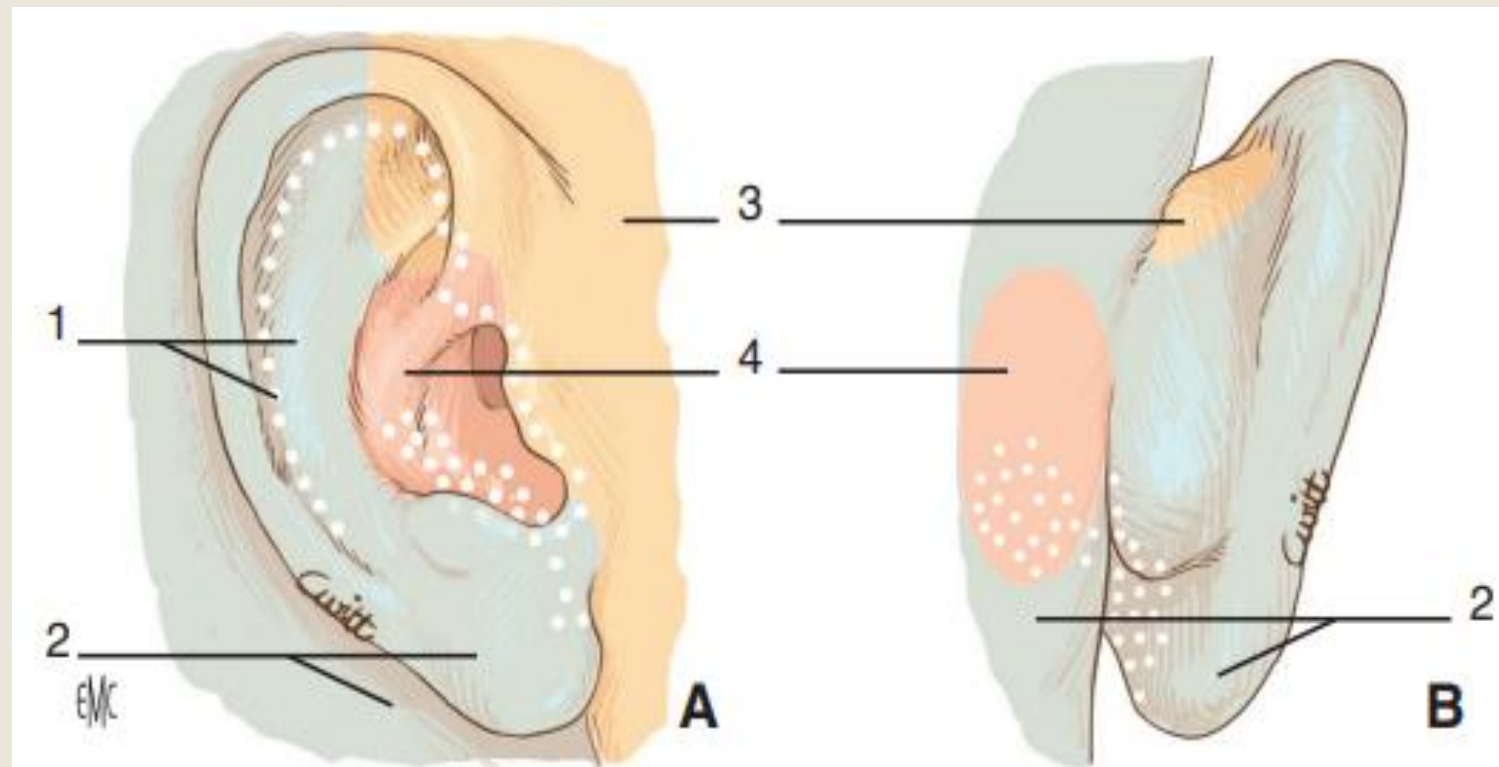


Figure 3. Innervation sensitive auriculaire. 1. Nerf facial ; 2. nerf trijumeau, nerf auriculotemporal ; 3. nerfs vague et glossopharyngien ; 4. plexus cervical, nerfs petit occipital et grand auriculaire.

INTERROGATOIRE – EXAMEN PHYSIQUE

A- L'interrogatoire

Moment essentiel dans la démarche diagnostique d'une algie faciale:

- **Caractéristiques sémiologiques de la douleur**, Il faut faire préciser :
 - les antécédents d'épisodes similaires ;
 - le facteur déclenchant (notamment **la zone gâchette**) ;
 - le mode d'installation (brutal ou progressif) ;
 - l'intensité de la douleur ;
 - la **nature** de la douleur (Éclair, coup de poignard, décharges électriques, sensation de serrement , brûlures, piqûres...) ;
 - le **siège** (douleur superficielle ou profonde, oculaire, auriculaire, dentaire, buccale...)
 - la périodicité avec durée des paroxysmes, avec ou sans fond douloureux entre les paroxysmes ;
 - les **signes associés** (notamment visuels : diplopie, baisse de l'acuité visuelle).

INTERROGATOIRE – EXAMEN

B- L'examen physique PHYSIQUE

Les différents éléments d'orientation suivants sont recherchés

- Un **syndrome de Claude Bernard Horner** qui associe
- un **ptosis**, un **myosis** et une **énophtalmie**
- Une ophtalmoplégie ou une **mydriase** : une paralysie douloureuse du **nerf oculomoteur commun (III)**
- Une hypo ou **anesthésie de la face et de la cornée**
- Une **claudication douloureuse de la mâchoire**, abolition du **pouls temporal**, fièvre ;
- Une **éruption vésiculeuse** d'un zona notamment au niveau de la naissance du cuir chevelu, les oreilles et les conduits auditifs ;
- Un **écoulement nasal**, **larmolement** ;
- Une **palpation des globes oculaires de façon comparative** : un œil douloureux et



Diagnostic étiologique***

- **Migraine***
- **-Névralgie essentielle du trijumeau ***
- **algie vasculaire de la face ***
- **Névralgie du Glossopharyngien**
- **Dissections des artères carotidiennes ***
- **Thrombose du sinus caverneux ***
- **Maladie de Horton ***
- **Dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire**

Migraine **

La migraine est une affection très fréquente (environ **1 milliard de patients dans le monde**) pouvant entraîner un handicap et une **altération de la qualité de vie** chez les individus qu'elle touche.

Il s'agit d'une **céphalée primaire** qui évolue par **crises** avec des **intervalles libres** où le patient ne présente aucun signe.

Il s'agit d'une affection bénigne qui n'entraîne aucune séquelle neurologique.

Migraine

Il existe deux types de migraine selon les critères **de l'International Headache Society (IHS)** :

la migraine sans aura (MSA) et la migraine avec aura (MAA).

Ces migraines avec ou sans aura typique sont faciles à reconnaître et ne nécessitent pas d'examen complémentaire,

Migraine**

Prédomine chez la femme

Diagnostic purement clinique (intérogatoire)

Premières crises surviennent à la puberté puis sont récurrentes tout au long de la vie

Plus fréquente chez l'adulte entre 30 et 50 ans

La fréquence peut aller de une fois /semaine à une fois /an

Svt ATCD familiaux

Facteurs déclenchants: stress ,menstruations, consommation de certains aliments (chocolat,alcool),certaines stimulations sensorielles(bruit,odeurs,lumière clignotante) ,modification du temps du sommeil,facteurs climatiques

Migraine sans aura **

La plus fréquente

Plus difficile à diagnostiquer

La douleur est d'installation progressive et atteint son maximum en 2 à 4h

Modérée à sévère n'atteint pas l'intensité d'autres formes de céphalées comme les algies vasculaires ou les névralgies du trijumeau

Non traitée elle peut durer jusqu'à 72 heures

Topographie classique: unilatérale, frontopariétale, parfois rétroorbitaire

Douleur classiquement pulsatile

Exacerbée par l'effort de caractère banal, les mvts de la tête, la toux, svt accompagnée de

Photophobie et de phonophobie et troubles digestifs (nausées, vomissements)

Le patient s'isole svt ds une pièce obscure et sans bruit et s'allonge

Examen neurologique normal | l'imagerie n'est pas indiquée ds les migraines typiques et ne montrent aucune anomalie spécifique

Migraine sans aura

Critères diagnostiques de la migraine sans aura selon l'International Headache Society (d'après [3]).

A. Au moins 5 crises répondant aux critères B à D

B. Crises céphalalgiques durant 4 à 72 h (non traitées ou traitées inefficacement)

C. Céphalée ayant au moins 2 des 4 caractéristiques suivantes :

- topographie unilatérale
- tonalité pulsatile
- intensité douloureuse modérée ou sévère
- aggravation par l'activité physique de routine ou limitation de cette dernière (par exemple marche ou montée des escaliers)

D. Durant la céphalée, au moins 1 des symptômes suivants :

- nausées et/ou vomissements
- photophobie et phonophobie

E. N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3

ICHD-3 : troisième édition de la Classification internationale des céphalées de l'International Headache Society.

Migraine avec aura

Critères diagnostiques de la migraine avec aura selon l'International Headache Society (d'après [3]).

A. Au moins 2 crises répondant aux critères B et C

B. Au moins 1 des symptômes totalement réversibles d'aura :

- visuel
- sensitif
- parole ou langage
- moteur
- du tronc cérébral
- rétinien

C. Au moins 3 des 6 caractéristiques suivantes :

- au moins 1 des symptômes d'aura se développe graduellement en au moins 5 min
- au moins 2 symptômes d'aura apparaissent successivement
- chaque symptôme de l'aura dure entre 5 et 60 min
- au moins 1 des symptômes d'aura est unilatéral
- au moins 1 des symptômes d'aura est positif
- l'aura est accompagnée ou suivie dans les 60 min d'une céphalée

D. Pas de meilleurs critères diagnostiques dans l'ICHD-3 et un accident ischémique transitoire a été éliminé

ICHD-3 : troisième édition de la Classification internationale des céphalées de l'International Headache Society

Migraine avec aura du tronc cérébral

Critères diagnostiques de la migraine avec aura du tronc cérébral.

A. Critères répondant aux critères de la migraine avec aura et au critère B

B. Aura avec absence de symptôme moteur ou rétinien + au moins 2 des symptômes du tronc cérébral suivants entièrement réversibles :

- dysarthrie
- acouphène
- vertige
- hypoacousie
- diplopie
- ataxie non attribuable à un déficit sensitif
- diminution du niveau de conscience (GCS < 13)

GCS : Glasgow Coma Score.

CAT**

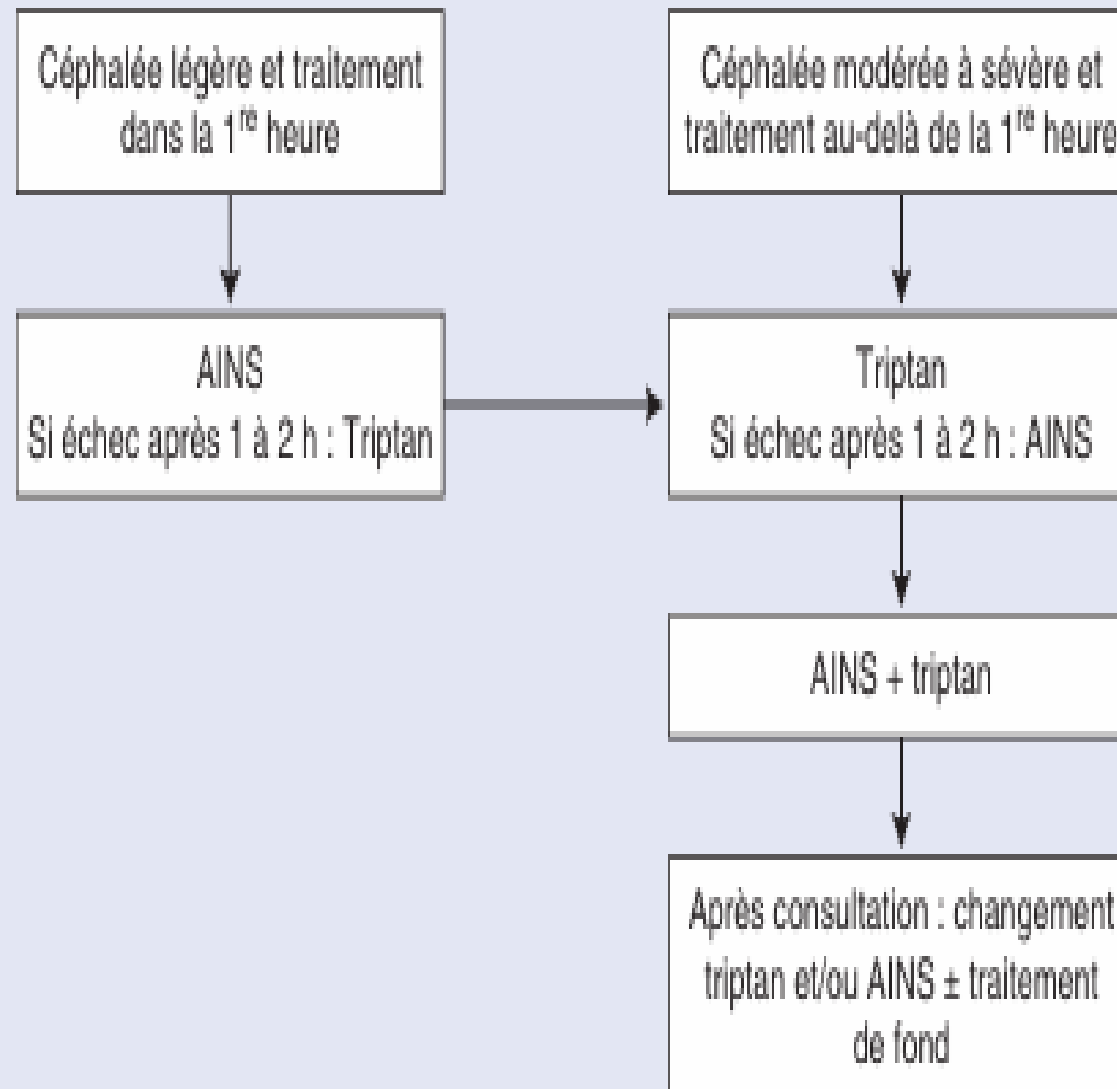
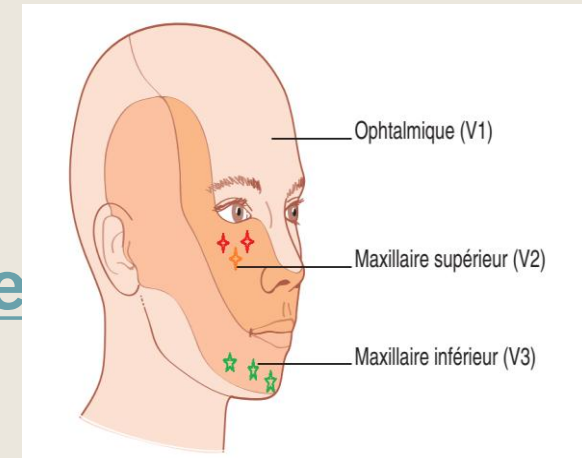


Figure 1. Arbre décisionnel. Stratégie du traitement de crise.
AINS : anti-inflammatoire non stéroïdien.

ALGIES FACIALES PRIMAIRES

A-Névralgie essentielle du trijumeau « Tic douloureux

Trousseau » **



Elle touche essentiellement les **femmes dans les cinquantaines**.

Son incidence est faible et elle affecte 0,07 % de la population

Résultent d'un contact entre une **boucle vasculaire et une branche du nerf trijumeau**, à son émergence de la base du crâne

Caractéristiques de la douleur :

- intense et paroxystique, précédée par des éclairs douloureux, à type **de décharges électriques**,
- brève, de **l'ordre de la seconde**. Parfois se répéter, réalisant une **salve de décharges** électriques qui peut durer **1 à 2 minutes**
- la fréquence des douleurs détermine la gravité. Dans les formes graves, les patients peuvent présenter **cinq à dix crises par jour**,
- les crises sont suivies d'une période réfractaire de 1 à 2 minutes où rien ne peut déclencher la crise.

ALGIES FACIALES PRIMAIRES

A-Névralgie essentielle du trijumeau « Tic douloureux de Trousseau » **

Topographie de la douleur. Strictement unilatérale Souvent limitée, notamment au début de l'affection, à l'une des branches du V.

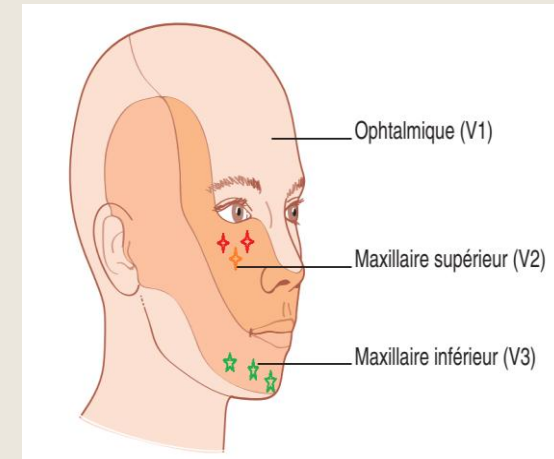
Le territoire maxillaire (V2) est le plus concerné, surtout au niveau **sous-orbitaire**.

Le territoire mandibulaire (V3) est aussi souvent concerné, plus particulièrement dans la zone d'innervation du **nerf mentonnier**

le **caractère souvent provoqué de la douleur**, par une **stimulation tactile** d'une région bien précise de la face ou du pharynx : **zone «gâchette» , parole, mastication, mimique...**

le **caractère négatif de l'examen neurologique** : pas de déficit sensitif dans le territoire nerveux considéré, pas de déficit moteur.

L'imagerie cérébrale n'est pas indiquée dans les névralgies essentielles du trijumeau, en dehors de **l'angio-IRM** pour diagnostiquer une **boucle vasculaire**, et sauf en situation d'échec de traitement médical de première intention



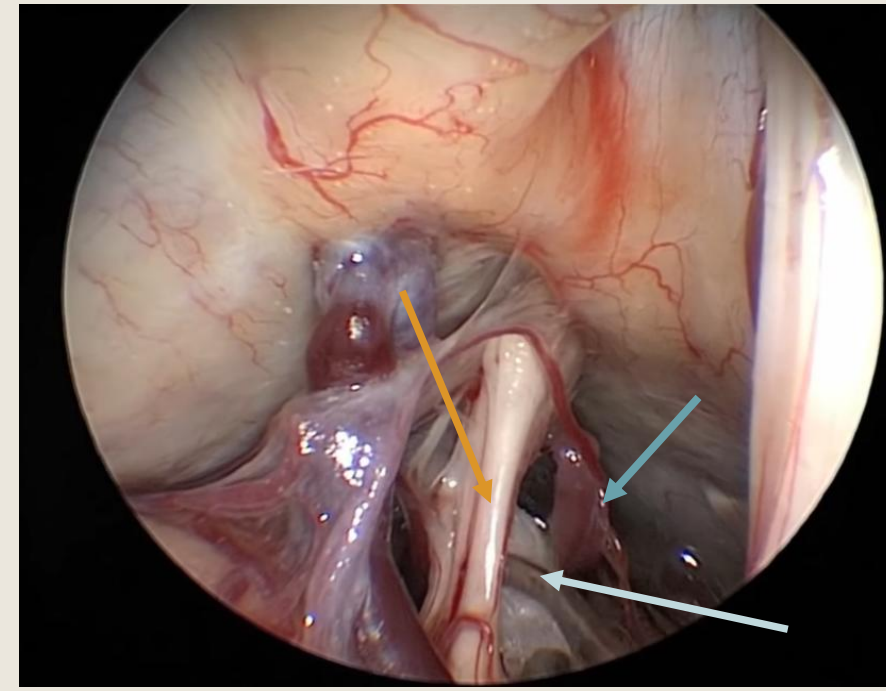
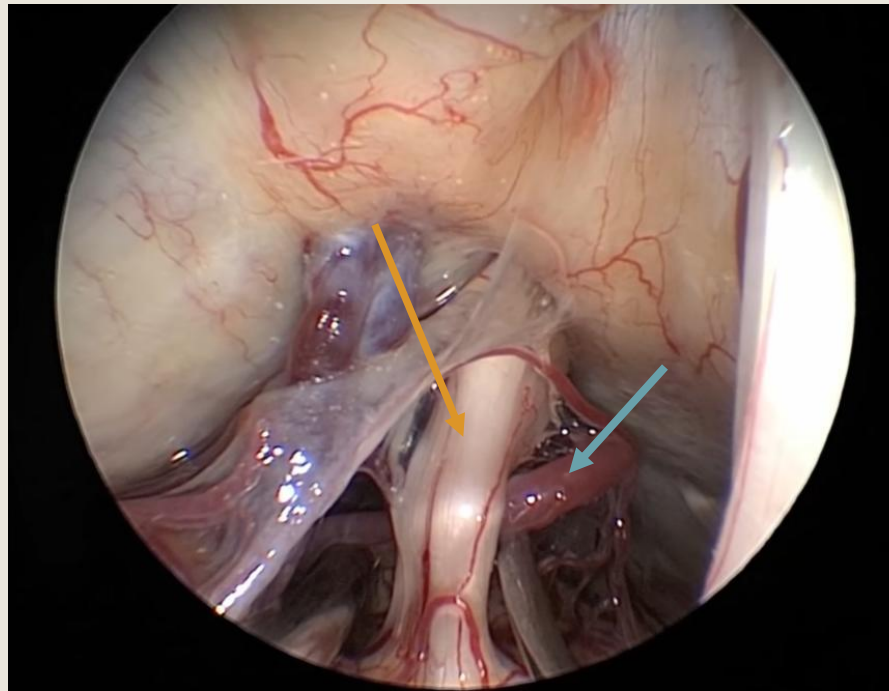
ALGIES FACIALES PRIMAIRES

A-Névralgie essentielle du trijumeau « Tic douloureux de Trousseau »

Le traitement de première intention : **la carbamazépine de 200 mg × 2/j.**

On peut proposer d'autres **antiépileptiques** ayant une action sur les douleurs **neuropathiques**

En cas d'échec un **traitement chirurgical de la boucle vasculaire** (interposition de Teflon)



ALGIES FACIALES PRIMAIRES

B- algie vasculaire de la face : **

Elle fait partie du groupe des céphalées trigémino-autonomiques qui ont en commun :

- le **caractère localisé et strictement unilatéral de la douleur**, dans les territoires trigéminaux ophtalmiques ou maxillaires ;
- la survenue régulière d'accès intenses relativement brefs pendant des périodes de durée variable ;
- l'association à **un dysfonctionnement sympathique**

Une des **affections humaines parmi les plus douloureuses**.

Sa prévalence est d'environ 0,1 à 0,4 % dans la population générale.

Elle touche habituellement les **hommes jeunes (sex-ratio homme/femme de 7/1)**.

L'âge de la première crise se situe entre **20 et 40 ans**



ALGIES FACIALES PRIMAIRES



B- algie vasculaire de la face **

Le tableau clinique est stéréotypé. Les crises surviennent souvent à la même heure avec une douleur possédant toujours les mêmes caractéristiques et la même durée.

Douleur:

- Localisation: **unilatérale à prédominance oculaire**, irradiant de façon homolatérale vers le front, la tempe, la pommette, la joue, la gencive supérieure, et, plus rarement, peut **s'étendre à toute l'hémiface**, ou encore à l'oreille, au cou et à l'hémicrâne, à la nuque voire à l'épaule homolatérale ;
- Type : brûlure, transpercement, déchirement, écrasement ;
- **Intensité: extrêmement sévère ;**
- Description chronologique: La douleur s'accroît en intensité jusqu'à **atteindre son acmé en 10 à 15 minutes**. Elle est **extrêmement violente**, s'accompagne souvent **d'agitation**, dure d'un **quart d'heure à 3 heures maximum**, puis cède **brusquement**.

ALGIES FACIALES PRIMAIRES

B- algie vasculaire de la face **

Les signes associés:

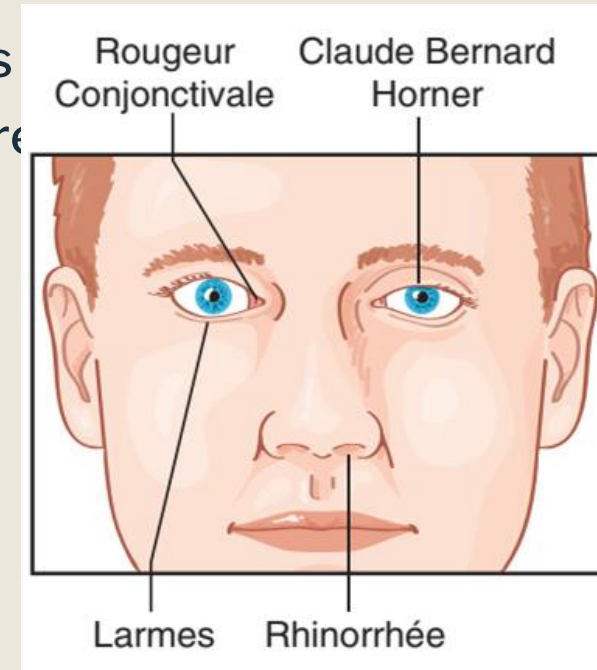
Il existe des phénomènes vasosécrétoires homolatéraux accompagnateurs dans le territoire du nerf trijumeau (notion de céphalées trigéminovasculaires)

- rougeur conjonctivale et/ou larmoiement
- narine bouchée et/ou écoulement nasal et/ou
- œdème palpébral et/ou rougeur de la face et/ou sudation de la face
- et/ou myosis et/ou ptosis.
- Au maximum, il peut exister un syndrome de Claude Bernard-Horner
- (myosis, ptosis, énophtalmie),

Evolution:

Les crises surviennent **deux à trois fois par jour en moyenne**, typiquement à horaire fixe, tous les jours pendant 2 à 8 semaines (elles sont dites récurrentes) avec des périodes de rémission très longues; il s'agit des formes dites épisodiques.

Le Tabac et l'alcool sont des facteurs aggravants



ALGIES FACIALES PRIMAIRES

B- algie vasculaire de la face

Diagnostic:

il est fondé sur l'interrogatoire et la normalité de l'examen neurologique.

Aucune imagerie ou autre exploration complémentaire n'est requise.

ALGIES FACIALES PRIMAIRES

B- algie vasculaire de la face **

Les algies vasculaires sont traitées par :

- triptans par voie sous-cutanée essentiellement, sumatriptan (Imiject®) est la première option. 6 mg en injection sous-cutanée de 0,5 ml. Son efficacité est de 75 %
- oxygénothérapie avec plus de 6 litres/min pendant 15 minutes.

Si le traitement des crises est insuffisant ou les crises trop rapprochées, un traitement de fond est possible avec plusieurs molécules possibles : vérapamil (Isoptine®) (le plus utilisé dans cette situation), indométacine, voire une cure courte de corticoïdes oraux.

Le tabac et l'alcool doivent être supprimés

Récapitulatif : Algies faciales

Sémiologie	Névralgie essentielle du trijumeau	Algie vasculaire de la face
Age	> 50 ans	20- 40 ans
Sexe	Femmes +++	Hommes+++
Type de la douleur	décharge électrique, de coup de poignard, de coupure	brûlure, transpercement, déchirement, écrasement
Localisation	Unilatérale V2 >>>V3	Unilatérale péri oculaire
Intensité	Intense et paroxystique	Extrêmement intense
Durée	Secondes à 2 minutes	15 à 180 minutes
Facteurs déclenchants	Zone gâchette, parole, mastication	Tabac alcool = facteurs aggravants
Signes vasomoteurs	Non	Oui: Rougeur conjonctivale, larmoiement, rhinorrhée, syndrome de Claude Bernard Horner
Examen neurologique	Normal	Normal
Imagerie	Boucle vasculaire	Normale
Traitement	Carbamazépine si échec décompression chirurgicale	Triptans + oxygénothérapie au masque Traitement de fond : Vérapamil

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

Causes
neurologiques

Causes
vasculaires

Causes
dermatologiques



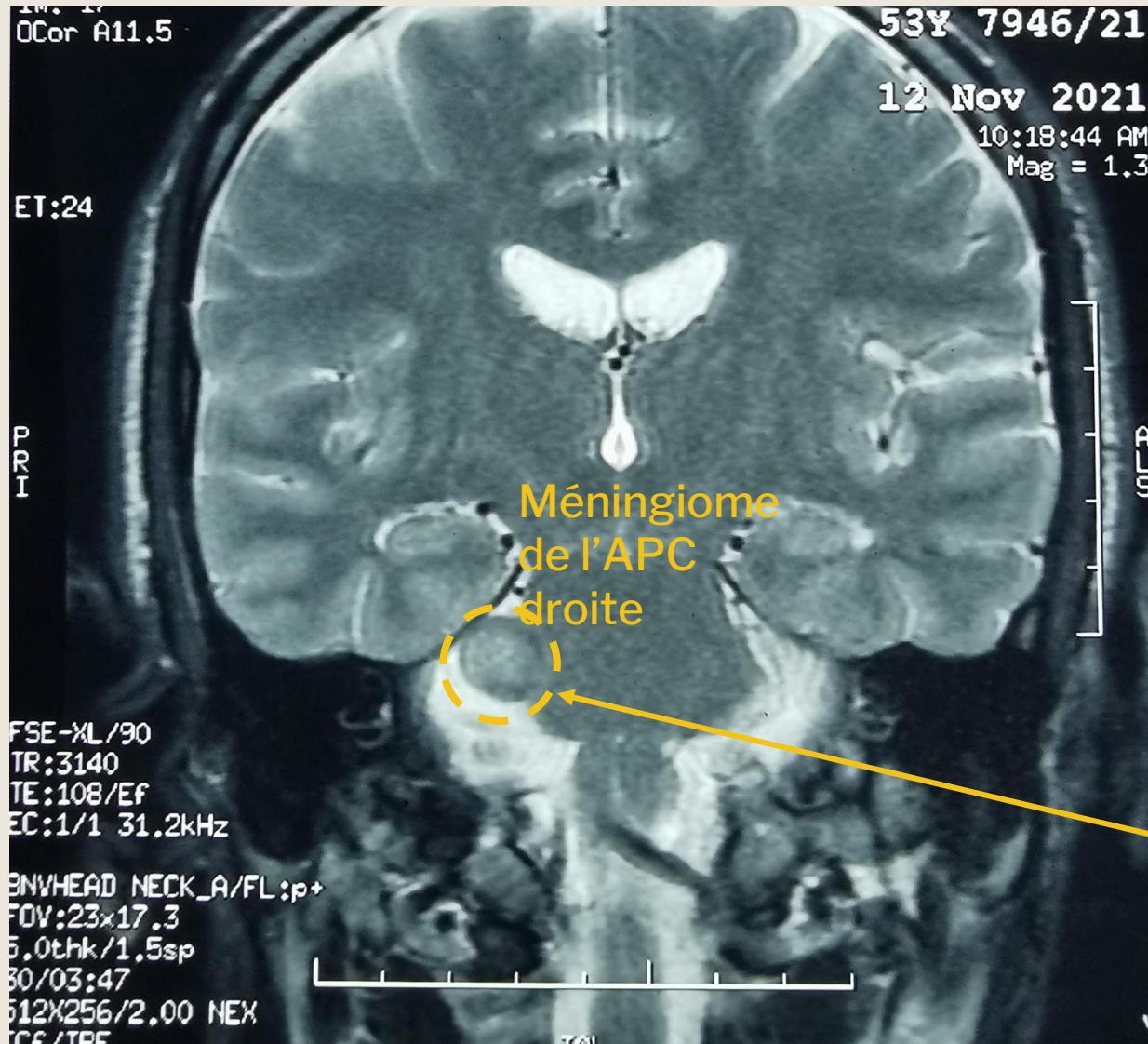
Causes
ophtalmologiques

Causes
ORL

Causes
Stomatologiques

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

I- Causes neurologiques:



secondaires à une pathologie sous-jacente.
Toute névralgie du trijumeau.

généralement identifiables par des
caractérisent par des déficits sensoriels
territoriaux du nerf trijumeau.

secondaires peuvent être tumorales,
post-traumatiques.

Causes Centrales

- **La sclérose en plaques (SEP) +++**
- La syringomyélie, les malformations de la charnière occipitale ;
- Les pathologies vasculaires (malformation artérioveineuse);
- Les tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux

ALGIES FACIALES SECONDAIRES



Parfois la névralgie
secondaire du trijumeau peut
présenter les mêmes
caractéristiques cliniques que
la névralgie essentielle du
trijumeau

I- Causes neurologiques:

A- Névralgie secondaires du Trijumeau

Sémiologie	Névralgie essentielle du trijumeau	Névralgie secondaire du trijumeau
Age	> 50 ans	Jeune (<50 ans)
Type de la douleur	décharge électrique, de coup de poignard, de coupure	Brûlures, arrachement, dysesthésies (sensations anormales provoquées par un stimulus ou le contact), Allodynies
Fond douloureux entre les crises	Non	Oui
Zone gâchette	Oui	Non +/-
Territoires du trijumeau concernés	Surtout un territoire Exceptionnellement bilatérale	Plusieurs territoires Voire Bilatérale
Signes vasomoteurs	Non	Possibles
Examen neurologique	Normal	Anormal: Déficit sensitif cutanéomuqueux dans le territoire intéressé, avec diminution du réflexe cornéen; atteinte motrice du V
Branches concernées	Principalement V2 Fréquemment V3	Principalement V1

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

I- Causes neurologiques:

A- Névralgie secondaires du Trijumeau:

Le traitement repose essentiellement sur celui de l'étiologie +++.

Un traitement symptomatique :

- *Un antidépresseur tricyclique, ou un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (duloxétine), ou*
- *Un anticonvulsivant (gabapentine et prégabaline),ou*
- *Un opioïde en cas de douleurs postzostériennes.*

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

I- Causes neurologiques:

B- Névralgie du Glossopharyngien:

Description :

- Localisation: début à la base de langue et/ou au niveau de l'amygdale, irradient vers l'angle mandibulaire et l'oreille ;
- Caractéristiques: intenses, strictement unilatérales, toujours profondes, parfois **syncopale**
- Facteurs déclenchants : les douleurs sont provoquées par la **déglutition**, la **parole**, le **bâillement**, l'**éternuement**, les **zones gâchettes sont la muqueuse pharyngée, l'amygdale ou l'oreille ;**
- Durée : de **quelques secondes à quelques minutes**, suivie d'une « période réfractaire »
- L'examen neurologique est strictement normal, sans signe déficitaire associé.
Les examens paracliniques sont normaux

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

I- Causes neurologiques:

B- Névralgie du Glossopharyngien:

■ Etiologies :

- La pathologie infectieuse : l'amygdalite, l'otite.
- La pathologie tumorale:
 - Soit cervicofaciale avec souvent une dysphonie, une dysphagie et un examen nasofibroscopique anormal (**tumeur des VADS**),
 - soit crâniofaciale avec les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure ou un neurinome du glossopharyngien (les symptômes associés sont l'abolition du réflexe nauséeux, une hypoesthésie, une parésie du voile et une atteinte des autres paires crâniennes).
- **Cause anatomique par compression du nerf IX faisant suite à une hypertrophie de l'apophyse styloïde ou à l'ossification du ligament stylohyoïdien : syndrome d'Eagle** ou stylalgie.
- Autres: **traumatismes cervicaux**, de **SEP**, de **tumeurs de l'amygdale**, de **tumeurs de l'angle pontocérébelleux**

NB: névralgie essentielle du glossopharyngien existe mais très exceptionnelle

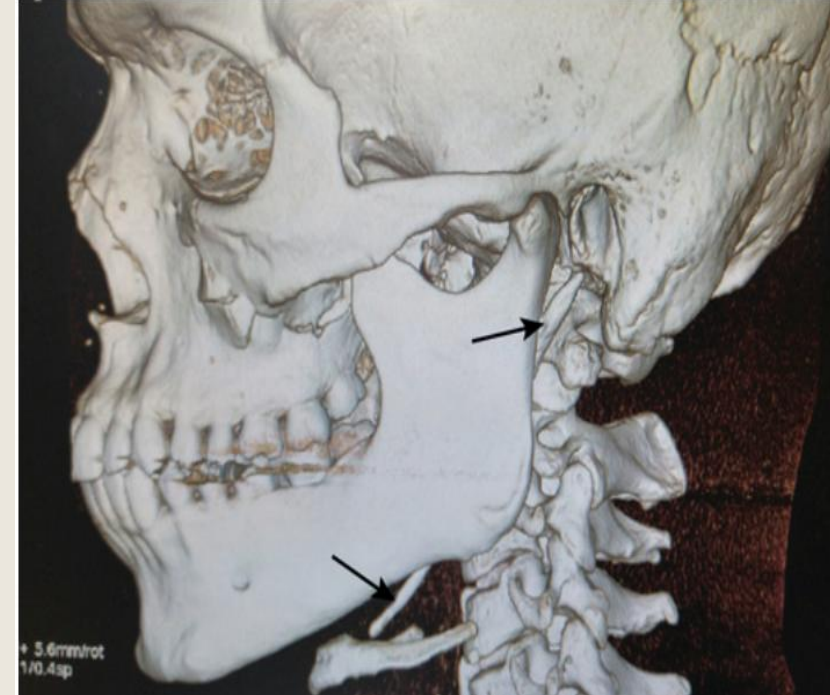
ALGIES FACIALES SECONDAIRES

I- Causes neurologiques:

B- Névralgie du Glossopharyngien:

■ Traitement :

- Même principe thérapeutique que névralgie du V
- **Syndrome d'Eagle:**
 - Le traitement médicamenteux: : la **carbamazépine** (400 mg/j) ou la **gabapentine** (300 mg/j), associée(s) à des **antalgiques de palier II**.
 - L'**injection en regard de la styloïde allongée**, c'est-à-dire du pilier antérieur de l'amygdale ou de la loge amygdalienne, d'un mélange hydrocortisone 25 mg dilués dans 1 ml de **lidocaïne** à 0,25 %, (bon test diagnostique si cela permet de calmer les douleurs)
 - La **styloïdectomie** par voie orale ou cervicale



ALGIES FACIALES SECONDAIRES

II- Causes vasculaires:

A- Dissections des artères carotidiennes **

Les dissections carotidiennes sont fréquemment responsables d'algies faciales. Souvent inaugurales, elles associent des céphalées pouvant irradier à la face, et/ou des **cervicalgies**.

Urgence neurologique : 73 % des dissections carotidiennes sont compliquées d'accident vasculaire cérébral et 20 % des accidents vasculaires cérébraux **du jeune**. Une autre complication vasculaire est **l'ischémie rétinienne (cécité monoculaire transitoire ou permanente)**

Les dissections de l'artère carotide interne s'accompagnent d'un **syndrome de Claude Bernard-Horner homolatéral, par atteinte du sympathique péricarotidien**.

Le diagnostic en urgence est confirmé **par l'échodoppler cervical, par l'IRM et l'angio-IRM cérébrale**.

Devant toute algie faciale atypique associée à un syndrome de Claude Bernard-Horner, il faut éliminer en urgence une dissection de l'artère carotide interne. ***

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

II- Causes vasculaires:

B- Thrombose du sinus caverneux **

La thrombose du sinus caverneux, septique ou aseptique, est **fatale dans près de 30 %** des cas, et elle peut être responsable de **séquelles neurologiques ou visuelles sévères**.

Il s'agit d'une affection particulièrement importante à connaître dans le cadre des algies faciales puisqu'elle peut compliquer des **affections neurologiques, ORL, stomatologiques ou dermatologiques**

Les céphalées généralement unilatérales, frontotemporales ou rétro-oculaires. Une **raideur de la nuque** est présente dans un tiers des cas. La fièvre peut être élevée si thrombose septique.

Les signes ophtalmologiques : **chémosis, œdème palpébral, ptosis**. paralysie de l'abduction oculaire (**paralysie du VI**), un syndrome de Claude Bernard Horner et **une baisse de l'acuité visuelle**.

Le diagnostic est porté par l'**imagerie**. Elle met en évidence une **asymétrie des sinus avec un bombement du sinus atteint et un défaut de vascularisation**.

Le **traitement est une urgence et associe un drainage chirurgical du foyer infectieux à une antibiothérapie intraveineuse probabiliste** : céphalosporine de troisième génération, métronidazole et vancomycine

L'**anticoagulation** efficace est systématique, même en cas de thrombose septique

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

II- Causes vasculaires:

B- Thrombose du sinus caverneux

Le diagnostic est porté par l'imagerie. Elle met en évidence une **asymétrie des sinus avec un bombement du sinus atteint et un défaut de vascularisation.**

Le traitement est une urgence et associe un drainage chirurgical du foyer infectieux à une antibiothérapie intraveineuse probabiliste : L'anticoagulation efficace est systématique, même en cas de thrombose septique.

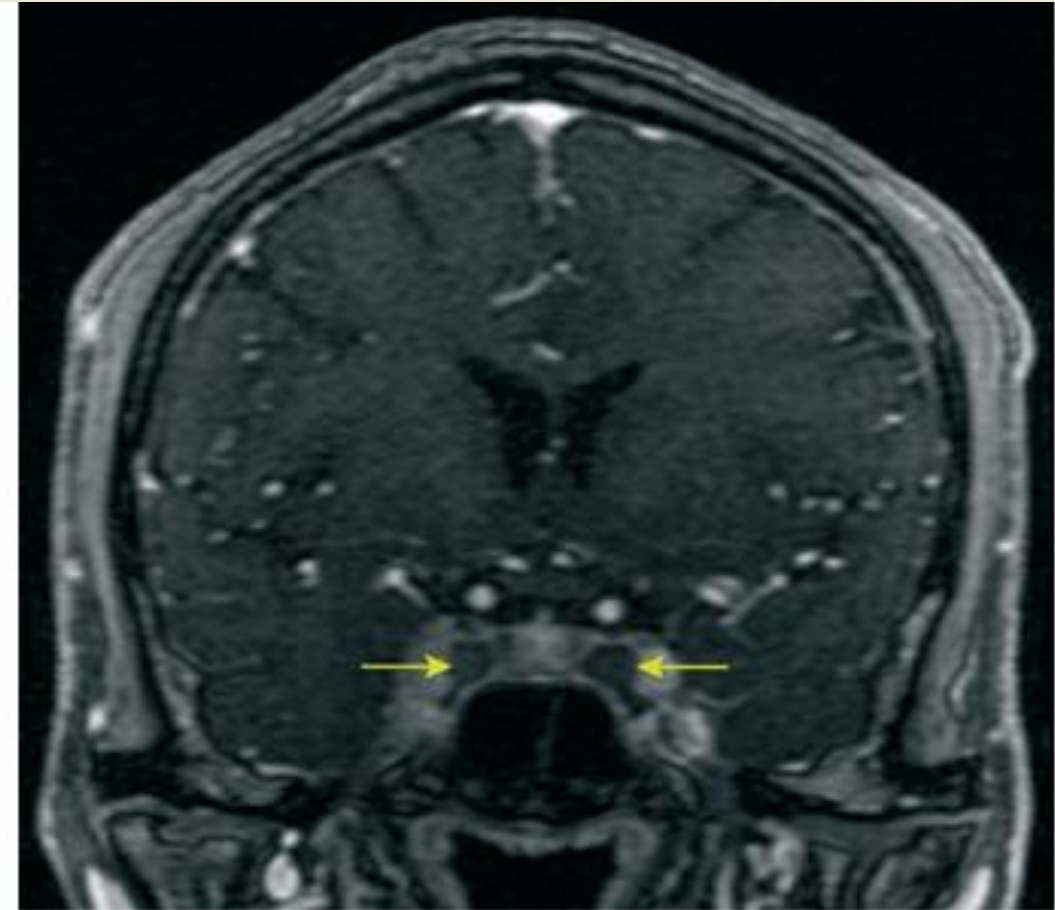


Figure 4. Thrombose bilatérale des sinus caverneux. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) injectée met en évidence l'absence de rehaussement avec un bombement des sinus caverneux droit et gauche (flèches).

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

II- Causes vasculaires:

C- Maladie de Horton: **

Cette **artérite gigantocellulaire** ;atteint préférentiellement **les artères de gros calibre**, avec une prédilection pour les branches de l'**ACE**.

Evoquée devant toute algie faciale et/ou céphalée d'apparition récente chez un **sujet de plus de 60 ans**, en particulier chez les **femmes**.

La douleur est le symptôme révélateur le plus fréquent. C'est une **douleur permanente** avec des **renforcements matinaux paroxystiques**, Elle est **exacerbée**, à type d'hyperesthésie, par **le contact avec le cuir chevelu** (**frottement du peigne, de l'oreiller, port de lunette, de chapeau...**).

Des **signes purement orofaciaux** : **douleur linguale**, **claudication intermittente** de la langue, **odontalgies**, **otalgies**. Mais c'est la **claudication intermittente de la mâchoire (+++)** qui est un signe pathognomonique de la maladie de Horton.*******

Au bout de quelques minutes de mastication, le patient ressent une fatigue, puis une douleur imposant l'arrêt provisoire de la prise alimentaire.

Des **douleurs rhizoméliques aux ceintures scapulaires et pelviennes**, sont rapportés dans la moitié des cas. Ce sont des signes également pathognomoniques.

Ce tableau s'accompagne d'une **altération de l'état général**.

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

II- Causes vasculaires:

C- Maladie de Horton:**

À l'examen, on recherche **des artères temporales indurées**, dilatées avec des nodosités, et sensibles. Le **pouls temporal peut être diminué, voire aboli**. Un **œdème facial**, peut être ressenti par le patient, voire même constaté à l'examen clinique.

Le bilan biologique, en urgence, montre un syndrome inflammatoire avec **une VS et une CRP augmentées**.

Le diagnostic doit être confirmé histologiquement par la **biopsie de l'artère temporale**, réalisée du même côté que la douleur.

Une corticothérapie doit être démarrée sans attendre pour éviter **les complications oculaires irréversibles** : **cécité par obstruction de l'artère centrale de la rétine**.

.

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

III- Causes dermatologiques:

A- Érysipèle facial (cellulite faciale superficielle)

C'une infection cutanée superficielle d'origine bactérienne qui touche la face dans 4 à 24 % des cas. Le germe responsable est généralement un **streptocoque bêta hémolytique** ; la surinfection par un staphylocoque doré est fréquente.

Il survient à tout âge, avec un âge moyen de 57 ans. Un facteur prédisposant local est retrouvé dans 80 % des cas : notamment une **affection dermatologique chronique**, une plaie, ou un antécédent local d'infection, de chirurgie ou d'irradiation.

Il se présente comme **une inflammation superficielle bien délimitée, douloureuse, avec érythème qui s'étend progressivement, associée à une fièvre et un syndrome inflammatoire biologique.**

Il est recommandé **d'hospitaliser le patient** les premiers jours du fait **du risque de thrombose du sinus caverneux, de cellulite périorbitaire ou orbitaire.** Ces complications sont cependant rares.

Traitement; **antibiothérapie par voie veineuse**

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

III- Causes dermatologiques:

B- Cellulite faciale profonde (cellulite cervicofaciale diffuse)

C' est **une infection cutanée et sous-cutanée d'origine bactérienne**. Plusieurs germes peuvent être impliqués : streptocoque, *Klebsiella pneumoniae*, staphylocoque ou *Pseudomonas aeruginosa*. Il s'agit d'une **affection grave** qui engage le **pronostic vital** et présente un risque important de **séquelle esthétique**.

Elle affecte le plus souvent des **sujets d'âge jeune**, avec un âge moyen de 28 ans. Un **foyer infectieux** est retrouvé dans presque tous les cas : **dentaire** (66 %), **amygdalien**, **sous-maxillaire**, **parotidien** ou **cutané**. La diffusion de l'infection à partir de ce foyer infectieux focal serait favorisée par **la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens dans 87 % des cas**,

L'infection s'installe sur une dizaine de jours avec pour présentation une tuméfaction tendue cervicale ou cervicofaciale. Les signes associés sont : **une fièvre**, **un trismus**, une **altération de l'état général**, une **fistule gingivale**, une **crépitation sous-cutanée**, une **tuméfaction présternale**, **une douleur thoracique**, . **L'extension médiastinale est de mauvais pronostic**.

Un **drainage chirurgical large** doit être pratiqué en urgence, en association à une antibiothérapie par voie veineuse

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

IV- Causes ophtalmologiques:

- Le glaucome aigu par fermeture de l'angle

C'est une **hypertension intraoculaire aiguë** par blocage de la résorption de l'humeur aqueuse dans l'angle de la chambre antérieure. responsable d'une **souffrance du nerf optique** qui **peut causer une cécité persistante**. Il peut être spontané ou déclenché par la prise de traitements : des gouttes mydriatiques pour fond d'œil, l'atropine, l'éphédrine systémique ou intranasale, les antihistaminiques, les antidépresseurs, le topiramate, ou les traitements inhalés de l'asthme (ipratropium, salbutamol ou terbutaline).

L'âge de survenue est généralement supérieur à 60 ans. Cliniquement: une baisse monoculaire de l'acuité visuelle, un halo autour des perceptions lumineuses, une **céphalée ou une douleur de la face**, une **douleur oculaire intense** et des **nausées-vomissements**. L'examen au lit met en évidence un **érythème conjonctival**, une **semi-mydriase peu réactive** et un **œdème de la cornée**. l'œil est de consistance « **dure comme du bois** »,

Il s'agit d'une **urgence ophtalmologique absolue** : une goutte à une minute d'intervalle de timolol maléate à 0,5 %, apraclonidine à 1 % et pilocarpine à 2 %, et deux comprimés de 250 mg d'acétazolamide.

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

V- Causes ORL:

Les sinusites algiques sont le plus souvent les *sinusites aiguës* qui suivent un « rhume » viral épidémique. Elles comportent des signes d'accompagnement (rhinorrhée, obstructions nasales) et des signes généraux souvent modestes (fièvre à 38 °C–38,5 °C).

La topographie des douleurs dépend du sinus en cause :

- jugale avec irradiation dentaire pour les **sinusites maxillaires** ;
- frontale pour les **sinusites frontales** ;
- du vertex ou rétro-orbitaire pour les **sinusites sphénoïdales** ;
- péri-orbitaire pour les **sinusites ethmoïdales**.

La position penchée en avant accentue les douleurs qui sont classiquement mais inconstamment plus intenses le matin que le soir. La pression de l'os maxillaire ou frontal en regard de la douleur majore cette dernière.

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

V- Causes ORL:

Les *sinusites chroniques* sont le plus souvent non pourvoyeuses de douleurs. Les symptômes sont plutôt à type de pesanteur.

Toutefois, **certaines sinusites chroniques frontales** ou **sphénoïdales** peuvent être extrêmement algiques, de sorte qu'une douleur chronique doit justifier un **scanner sinusien**.

Les **cancers nasosinusiens** peuvent être pourvoyeurs de douleurs, surtout s'il existe un envahissement osseux de l'étage moyen ou antérieur, ou une extension orbitaire. Il existe généralement d'autres symptômes : **rhinorrhée purulente**, **obstruction nasale** et **épistaxis**, qui ont tendance à augmenter progressivement et sont unilatéraux.

L'**endoscopie** et le **scanner** permettent le diagnostic.

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

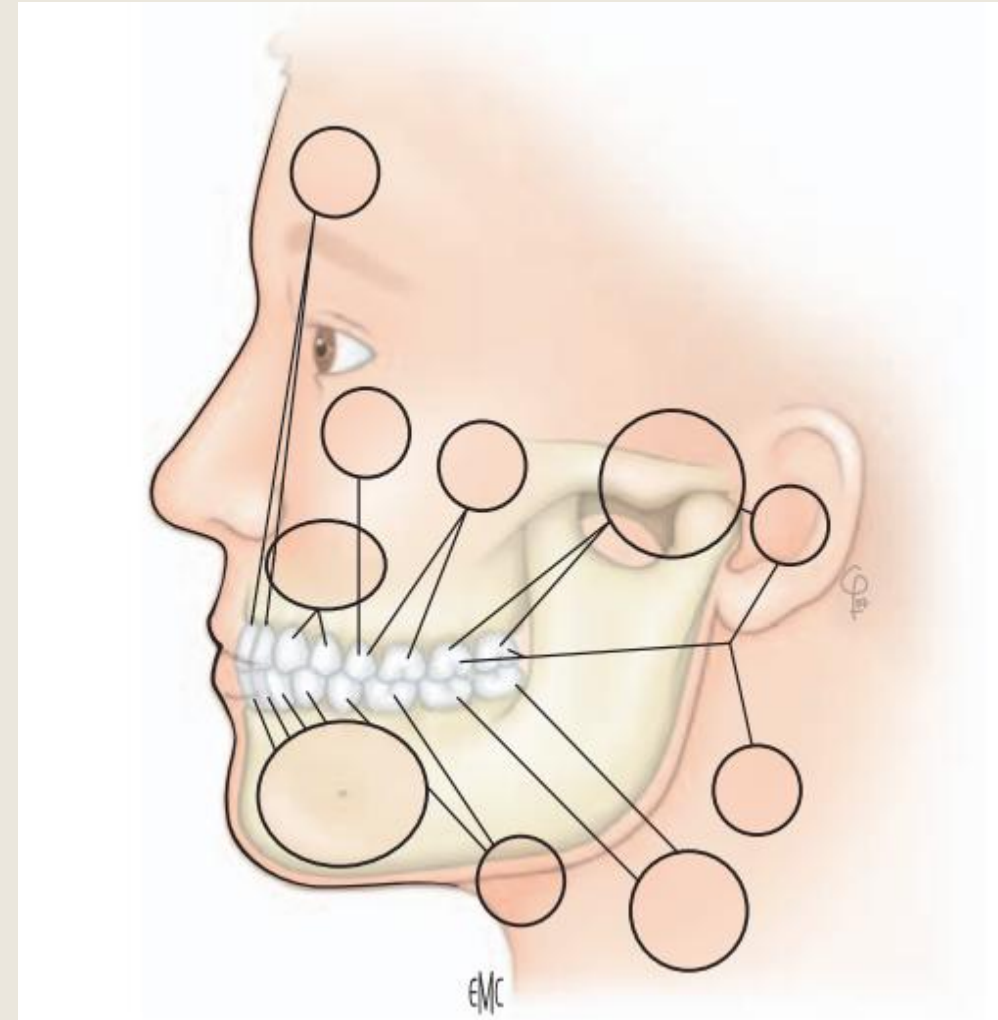
VI- Causes stomatologiques:

A- Douleurs dentaires:

La pathologie dentaire est une cause fréquente de douleur faciale. C'est pourquoi il est important d'interroger le patient sur ses antécédents dentaires, et sur **des facteurs déclenchants comme le contact du froid ou la mastication.**

La **pulpite** est responsable d'une douleur mal localisée déclenchée par le chaud ou par le froid, totalement ou partiellement soulagée au retrait du stimulus. En cas d'extension, le risque est **la pulpite purulente** avec une douleur intense irradiant dans toute la cavité buccale.

Une prise en charge spécialisée rapide est nécessaire à la fois pour soulager la douleur à sa cause, et pour éviter **l'abcédation ou la cellulite faciale profonde.**



Territoires de projections douloureuses correspondant à une pathologie dentaire

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

VI- Causes stomatologiques:

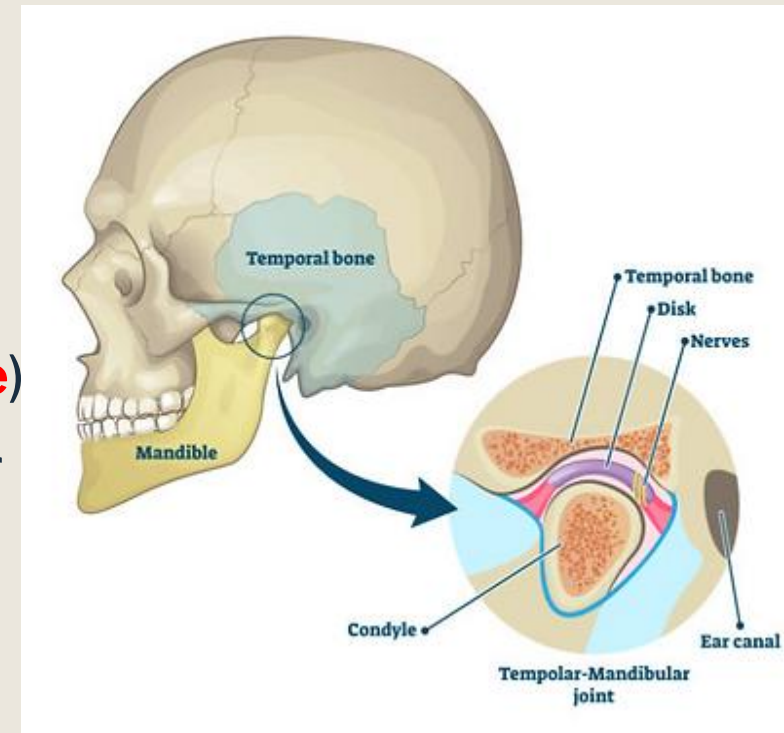
B- Dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire:

Les troubles ou dysfonctions de l'ATM sont un terme générique, également dénommée le syndrome algodysfonctionnel de l'appareil manducateur. Ils concernent 5 à 12 % de la population générale.

Ils incluent une symptomatologie qui concerne les muscles masticateurs, l'ATM et les structures adjacentes.

Les douleurs peuvent être au niveau de la musculature masticatrice (**céphalées de tension, douleurs cervicales**, etc.) ou au niveau de l'ATM (**synovite, capsulite, arthrose** ou **arthrite**)

Ils résultent d'un défaut d'adaptation de l'appareil manducateur à un trouble de l'occlusion ou à une para fonction (crispation des mâchoires, grincement des dents...), majoré par un trouble d'ordre **psychique** ou général (**stress**)



ALGIES FACIALES SECONDAIRES

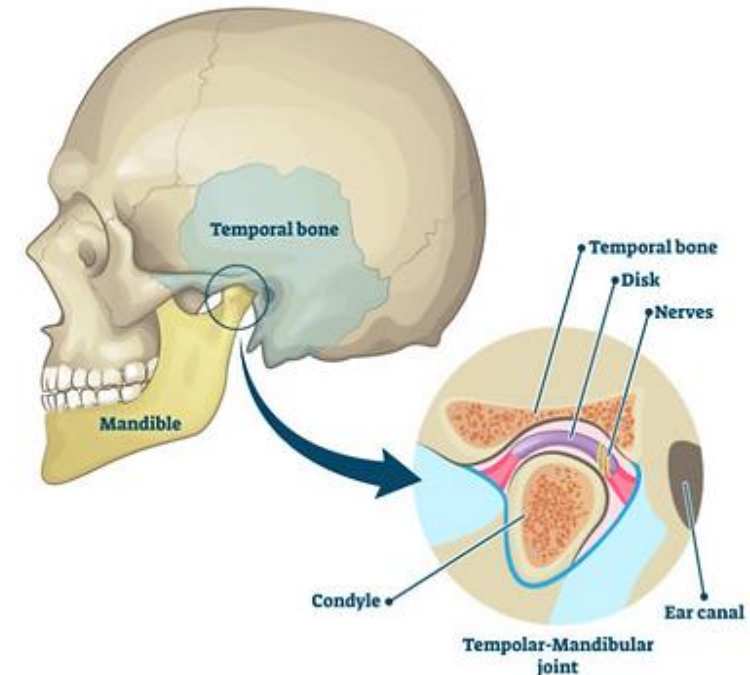
VI- Causes stomatologiques:

B- Dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire:

Des signes dysfonctionnels (**claquement**, **blocage de l'ATM** et limitation des mouvements) peuvent être présents, mais pas nécessairement associés à des douleurs. Il convient maintenant de dissocier les douleurs orofaciales liées aux muscles, les douleurs orofaciales liées à l'ATM et les signes dysfonctionnels.

Les douleurs sont préférentiellement localisées aux régions temporales, préauriculaires et/ou aux muscles masséters.

Elles sont plus fréquemment unilatérales, mais peuvent devenir bilatérales. Une douleur référée au visage est commune.



ALGIES FACIALES SECONDAIRES

VI- Causes stomatologiques:

B- Dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire:

- *Traitement médical: AINS, myorelaxant*
- *Toxine botulinique*
- *Supprimer toutes les mauvaises habitudes prises par le patient*

Arrêter l'usage de chewing-gum et des **mauvaises habitudes de morsures**

Eviter les aliments durs ou ceux qui requièrent une ouverture buccale forcée. Par exemple couper une pomme en morceaux plutôt que d'y mordre à pleines dents ;

Limitier les ouvertures de bouche brutales, importantes et prolongées (lors du bâillement, en chantant...et lors de soins dentaires).

Remédier aux moments de crispation des mâchoires (lors d'un effort physique ou lors d'un effort de concentration intellectuelle) : faire des **exercices d'automassages des muscles masticateurs**

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

VI- Causes stomatologiques:

B- Dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire:

- **Rééducation fonctionnelle, acupuncture**
- **Les traitements occlusaux :** le **port d'une gouttière occlusale** dont les objectifs sont : la stabilisation de la mandibule lors de la fermeture, le reconditionnement de la musculature et un recentrage articulaire (diminution des pressions intra-articulaires, réaménagement des relations condylodiscales : repositionnement discal). Le résultat obtenu est ensuite stabilisé par des thérapeutiques occlusales définitives par moulage, prothèse, orthodontie, chirurgie orthognatique des bases osseuses pour fermer une béance antérieure par exemple.

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

VII- Douleurs orofaciales idiopathiques:

Ce sont des douleurs mal comprises, de mécanisme imparfaitement identifié et de traitement difficile. Le **profil psychologique particulier** des patients souffrants, leur demande pressante de soulagement et l'impossibilité du praticien à y répondre compliquent encore la situation.

Stomatodynie (glossodynie ou “burning mouth syndrome”) BMS

Il s'agit d'une entité douloureuse de la **muqueuse buccopharyngée, langue, palais, gencive, lèvres, pharynx, sans cause organique.**

Ce syndrome touche les **femmes**, en **postménopause**, dans la **soixantaine**, avec souvent une notion de cancérophobie. Son étiologie serait **neuropathique**

Le patient décrit une douleur continue, chronique, le plus souvent bilatérale, symétrique, à type de **brûlure**. Sa forme la plus connue est sa localisation linguale, aux deux tiers antérieurs (**syndrome de la langue brûlante**). Elle est diurne et s'aggrave au cours de la journée, pour être maximale à l'endormissement.

Elle peut rarement être accompagnée de dysesthésies localisées de la muqueuse buccopharyngée, mais sans **aucune lésion visible**..

ALGIES FACIALES SECONDAIRES

VII- Douleurs orofaciales idiopathiques:

Stomatodynie (glossodynie ou “burning mouth syndrome”)

Généralement spontanée, elle peut aussi être déclenchée ou aggravée par l'ingestion d'aliments épicés ou acides. La prise de nourriture ou de boisson peut diminuer les sensations douloureuses (**chewing-gum**). Des signes subjectifs comme **sensation de soif**, de **bouche sèche** ou de **troubles gustatifs** accompagnent la douleur.

Il faut écarter les causes locales, radiothérapie, mucites postchimiothérapiques, xérostomie due à des médicaments psychotropes et exclure les causes systémiques (syndrome de Sjögren, diabète, carence vitaminique). L'examen peut retrouver une **langue animée de mouvements incessants**,

La prise en charge repose sur **l'éviction des facteurs irritants** (aliments acides, alcool, tabac, bains de bouche alcoolisés) et **l'hydratation par l'eau et les chewing-gums sans sucre**.

Des médicaments comme les **antidépresseurs**, les **anxiolytiques** et la **gabapentine** peuvent être prescrits.

La **thérapie cognitivo-comportementale (TCC)**, la **gestion du stress**, ainsi que des suppléments de **vitamines B et C** sont aussi des options

CONCLUSION

Les algies cranio-faciales primaires ne nécessitent pas d'examen complémentaire, sauf s'il s'agit du premier épisode ou s'il est différent des épisodes habituels.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'urgences vitales ou fonctionnelles, il faut savoir soulager la douleur par des traitements spécifiques, notamment **l'oxygénothérapie à haut débit et les triptans injectables pour l'algie vasculaire de la face.**

Une approche systématique permet de distinguer les différentes causes d'algies cranio-faciales secondaires et d'identifier les situations nécessitant un examen complémentaire, un traitement spécifique ou une prise en charge spécialisée.

Il s'agit notamment d'une imagerie cérébrale et vasculaire devant un **Claude Bernard Horner, un trouble oculomoteur ou une suspicion de pathologie du sinus caverneux.**

Une **NES et une CBP** sont réalisées devant toute algie faciale après 50 ans